Тема 13. БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА (НАРКОТИЧЕСКИЕ И НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ)

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Опиоидная система: рецепторы, функции, механизм обезболивающего действия опиоидов.
2. Морфин. Фармакологические эффекты. Показания к назначению. Противопоказания. Побочные эффекты.
3. Отравление морфином: симптомы, меры помощи. Признаки зависимости к морфину.
4. Синтетические опиоидные анальгетики: Промедол, Просидол, Фентанил - фармакологические свойства, особенности применения, показания, побочные эффекты.
5. Анальгетики со смешанным механизмом действия: Трамадол: фармакологические эффекты, особенности применения, показания для назначения, побочные эффекты.
6. Классификация ненаркотических анальгетиков. Механизм анальгетического действия нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
7. Фармакологические и побочные эффекты НПВС.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Антагонисты опиоидных рецепторов Налоксон и Налтрексон: фармакологические эффекты и применение.
- Лекарственные вещества различных групп, обладающие дополнительным (побочным) анальгетическим действием.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. В больницу доставлен пациент через 3 часа после приема большой дозы морфина. Состояние средней тяжести.
   1) Есть ли необходимость промывания желудка?
   2) Перечислите симптомы характерные для отравления морфином.
   3) Существует ли антидот морфина?

II. У больного после приёма неизвестного вещества развилось сопорозное состояние, с ригидностью мышц и отсутствием реакции на слабые и средние раздражители, только на громкий окрик он делал попытку открыть глаза. При объективном обследовании: зрачки резко сужены, пульс 58 ударов в минуту, дыхание 6 – 8 в минуту, глубокое, аритмичное, коленный рефлекс повышен, при пальпации определяется наполненный мочевой пузырь.

1) Предположите каким препаратом произошло отравление?
2) Предложите меры помощи.
3) Какие лекарственные средства имеет ограничения оборота на территории РФ и в чём они состоят?

III. Пациент 40 лет доставлен в приемное отделение с жалобами на боли в эпигастрии в течение последних суток, слабость и головокружение. Из анамнеза известно, что в течение длительного времени принимал какой-то препарат по поводу болей и припухлости суставов. Последние дни отмечал темный стул. При лабораторном исследовании –снижение содержания гемоглобина и количества эритроцитов.
1) Предположите какой препарат принимал пациент?
2) Какие у него развились осложнения?
3) Каким образом можно уменьшить риск подобных осложнений?

IV. Ребенку 6 лет на фоне острой вирусной респираторной инфекции было назначено жаропонижающее средство в таблетках. Через 4 дня на фоне начинающегося выздоровления изменилось поведение ребенка, на вопросы отвечает невпопад и неадекватно реагирует, на коже появилась сыпь, затем присоединилась рвота, которая приняла неукротимый характер.
1) Предположите какое осложнение развилось у ребенка, его причины?
2) Какой препарат был назначен в качестве жаропонижающего средства?
3) Перечислите возможные осложнения связанные с применением данной группы препаратов.

Тестовые задания

1. Побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты:
   1) Психическая зависимость
   2) Кровоточивость
   3) Ульцерогенный эффект
   4) Синдром Рея

2. Антагонистом опиоидных рецепторов является:
   1) Трамал
   2) Налоксон
   3) Морфин
   4) Промедол

3. Антагонистом опиоидных рецепторов является:
   1) Трамал
   2) Налоксон
   3) Морфин
   4) Промедол

4. Привыкание (толерантность) к наркотическим анальгетикам характеризуется:

1) Непереносимостью препарата
2) Необходимостью снижения дозы препарата для достижения эффекта
3) Необходимостью повышения дозы препарата для достижения эффекта

5. Морфин оказывает следующие эффекты:
    1) Миоз
    2) Вызывает бронхоконстрикцию
    3) Вызывает рвоту
    4) Подавляет кашель

6. Укажите правильные утверждения:
    1) Налоксон устраняет психическую и физическую зависимость к опиоидам
    2) Налоксон снижает депрессию дыхания при отравлении опиоидами
    3) Налоксон вызывает развитие абстиненции у наркоманов

7. Основные фармакологические эффекты анальгетиков-антипиретиков:
    1) Антигистаминное
    2) Противовоспалительное действие
    3) Антиагрегационное
    4) Анальгетическое
    5) Жаропонижающее

8. Острое отравление морфином сопровождается
    1) Снижением температуры тела
    2) Расширением зрачка
    3) Угнетением дыхания
    4) Брадикардией
    5) Расслаблением сфинктеров гладкой мускулатуры

9. Морфин вызывает сужение зрачка, так как
    1) Возбуждает холинорецепторы круговой мышцы радужки
    2) Блокирует адренорецепторы радиальной мышцы радужки
    3) Стимулирует центры глазодвигательного нерва
    4) Вызывает сокращение куговой мышцы радужки

10. При остром отравлении морфином проводят
    1) Введение антихолинэстеразных средств
    2) Промывание желудка
    3) Введение налоксона
    4) Искусственное дыхание

11. Индометацин
    1) Снимает острые боли
    2) Снимает хронические боли
    3) Снижает синтез простагландинов
    4) Обладает спазмолитическим действием
    5) Применяется при ревматизме

12. Ульцерогенное действие ацетилсалициловой кислоты определяется
    1) Усилением выработки гастрина
    2) Нарушением синтеза гастропротективных простагландинов
    3) Прямым раздражающим действием на слизистую желудка
    4) Стимулирующим влиянием на центры блуждающих нервов

Выпишите рецепты

1. Морфин (род. Morphini) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой
2. Тримеперидин (род. Trimeperidini) – таблетки
3. Ацетилсалициловая кислота (род. Acidi acetylsalicylici) – таблетки
4. Нимесулид (род. Nimesulidi) - гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь
5. Диклофенак (род. Diclophenaci) – суппозитории ректальные
6. Диклофенак (род. Diclophenaci) – гель для наружного применения
7. Кеторолак (род. Ketorolaci) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой